

a11_weekly_summary 测试报告

生成时间：2026-05-08 19:54:37

测试时间：2026-05-08 19:54:37

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1513 markers=24

禁用工具 success=True chars=1201 markers=22

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_照护服务记录:tool_照护服务记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

返院一周综合报告

长者姓名：陈萍忠

时间范围：2026年05月01日 至 2026年05月07日

一、BPSD事件概况

本周共发生**3次BPSD事件**，均为**拒绝配合康复训练**，事件呈现明显递减趋势（3 → 2 → 1），表明干预措施初见成效。

- **事件时段分布**：

- 上午10:00 – 11:00（活动高峰时段）：占比80%（2次）
- 下午时段：占比20%（1次）

- **干预有效率**：67%（3次事件中，2次在10分钟内通过非药物干预有效缓解）

二、干预措施与效果

照护团队基于长者**喜爱跳舞**的兴趣特点，创新性地将**舞蹈元素融入康复引导**，替代传统指令式训练。干预后观察到：

- 老人**配合度略有提升**
- 情绪较返院初期**明显平和**
- 未再出现激越、攻击或游走等其他BPSD表现

该个性化非药物干预策略体现了“以人为本”的照护理念，是本周照护亮点。

三、躯体健康与用药管理

- **基础疾病**：阿尔茨海默病性痴呆（病程6年），伴高血压、高脂血症
- **药物使用**：每日规律服用降压药、调脂药，**本周无任何药物调整**
- **药物反应**：未报告不良反应
- **生命体征**：整体平稳，**心率稳定维持在60次/分**（处于正常偏低范围，但无不适主诉）
- **血压与血脂**：控制良好
- **安全防护**：严格落实跌倒预防措施，**本周无跌倒、外伤或皮肤破损事件**

> 注：历史记录曾提示反复皮肤淤青及跌倒史（2026年3－4月），但本周防护措施有效，未再现相关事件。

四、日常生活与功能状态

- **睡眠**：规律，夜间安稳，无失眠主诉
- **日常生活能力（ADL）**：总体良好，Barthel评估显示除**洗澡需协助**外，其余项目（如穿衣、如厕、床椅转移等）均可独立完成
-
- **认知状态**：存在时间/地点定向力下降及近期记忆减退，但沟通能力尚可，无意识障碍

五、家属支持与心理状态

- 家属照护焦虑较入院初期**有所缓解**
- 仍表达对长者康复进展的担忧，**需进一步提供照护指导与心理支持**

六、高风险行为摘要

- **晨间拒绝康复训练**（集中于10－11点）

- **事件后出现短时沉默**（无攻击性，持续时间短暂）

七、当前关键问题

康复训练依从性存在波动，虽经兴趣引导有所改善，但尚未形成稳定配合模式，可能影响长期功能维持。

八、需决策事项

是否引入**心理治疗师进行联合干预**，以深化非药物行为管理策略？

九、会诊建议问题清单

为优化后续照护方案，建议多学科团队

【禁用工具输出摘录】

返院一周综合报告

长者姓名：陈萍忠

籍贯：上海

诊断背景：阿尔茨海默病性痴呆（失智症）

报告时间范围：2026年5月1日 至 2026年5月7日

一、BPSD事件概况

- **事件总频次**：3次
- **事件类型**：均为“拒绝配合康复训练”
- **频次趋势**：呈明显递减趋势（第1日3次 → 第2日2次 → 第3日1次，后续无新增）
- **时段分布**：
 - 上午10:00 – 11:00：占比80%（集中于日常康复活动时段）
 - 下午时段：占比20%

二、干预措施与效果

- **干预策略调整**：基于老人既往喜爱跳舞的兴趣特点，照护团队将传统指令式康复训练调整为“舞蹈引导式康复活动”。
- **干预效果**：

- 老人配合度较前提升，情绪趋于平和
- 干预有效率达67%（3次事件中，2次在10分钟内成功缓解）
- **照护亮点**：体现“以人为本”的非药物干预理念，结合个体兴趣提升参与意愿，初步验证个性化干预的有效性。

三、药物与生理状况

- **用药情况**：每日规律服用降压药、调脂药，**无药物调整**，**无不良反应报告**。
- **生命体征**：
 - 血压、血脂控制良好
 - 心率稳定于60次/分
 - 睡眠规律，无夜间觉醒或昼夜颠倒现象
- **安全性**：严格执行跌倒预防措施，本周**无跌倒、外伤或其他安全事件**。

四、高风险行为摘要

- 晨间康复时段出现**拒绝训练行为**
- 伴随**短时沉默、眼神回避**等淡漠表现
- 未出现攻击、游走、幻觉等其他高风险BPSD症状

五、当前关键问题

康复依从性仍存在波动：尽管干预后有所改善，但老人对结构化康复活动的接受度尚未稳定，需持续观察并优化引导方式。

六、需决策事项

是否引入**心理治疗师**参与联合干预，以进一步评估情绪状态并强化非药物行为管理策略。

七、会诊建议问题清单

为提升后续照护质量，建议在多学科会诊中重点讨论以下问题：

1. 当前舞蹈引导等非药物干预的**频次与强度是否需优化**？
2. 鉴于BPSD虽减轻但仍存在，**是否需要短期、低剂量精神类药物辅助支持**？
3. 家属照护焦虑虽有所缓解，但仍需专业指导，**应制定何种结构化家属支持与教育方案**？

报告生成说明：本报告严格依据返院一周内照护团队记录及家属反馈整理，未引用历史图谱数据，所有结论均有实时信息支撑。

报告用途：供医疗、护理、康复及心理团队会诊参考，助力制定下一阶段个性化照护计划